

Embarazo ectópico

1. Introducción y relevancia clínica

El **embarazo ectópico (EE)** se define como la **implantación del blastocisto fuera de la cavidad uterina**.

Afecta aproximadamente **1–2% de todos los embarazos**, y en Chile representa una **urgencia obstétrica frecuente** en los servicios de ginecología y maternidad.

La localización más común es la **trompa de Falopio (~98%)**, especialmente en la **porción ampular (70%)**, aunque puede implantarse en otras zonas: ístmica, intersticial, cervical, ovárica o abdominal.

La **ruptura tubaria con hemoperitoneo** es una causa clásica de shock hipovolémico en mujeres jóvenes, y su diagnóstico debe realizarse precozmente antes de llegar a esa etapa.

- En el EUNACOM, el embarazo ectópico suele evaluarse a través de casos clínicos con:
 - Dolor pélvico unilateral + atraso menstrual + test de embarazo positivo.
 - Ecografía sin saco intrauterino + masa anexial o líquido libre.
-

2. Fisiopatología y bases conceptuales

La implantación ectópica ocurre cuando el **óvulo fecundado no logra alcanzar la cavidad uterina**, generalmente por **daño o alteración anatómica/tubaria**.

Factores predisponentes:

Tipo	Ejemplos
Tubarios	EPI (clamidia, gonorrea), cirugías tubarias, ligadura previa, malformaciones congénitas.
Hormonales	Uso de anticonceptivos con solo progestina, DIU (embarazos raros pero casi siempre ectópicos).

Reproductivos Fertilización in vitro, embarazo previo ectópico.

Otros Tabaquismo (altera motilidad ciliar).

Fisiopatología:

1. El óvulo fecundado se detiene en la trompa.
 2. Se implanta y forma vellosidades coriales invasivas.
 3. Aumenta la hCG, pero el trofoblasto crece en una pared no distensible.
 4. Se produce erosión vascular y, si no se interviene, **ruptura y hemorragia intraperitoneal**.
-

3. Clínica: diagnóstico diferencial y presentación típica

a.

Tríada clásica del embarazo ectópico

1. **Atraso menstrual.**
2. **Dolor pélvico o abdominal unilateral.**
3. **Sangrado vaginal escaso o irregular.**

Sin embargo, esta tríada **solo está presente en un 40–50% de los casos.**

b.

Signos adicionales

- Dolor referido a hombro (irritación diafragmática por sangre intraperitoneal).
- Mareo, lipotimia o signos de shock (ruptura tubaria).

- Utero menor al esperado según FUR.
- Masa anexial dolorosa al tacto.
- Dolor intenso con puño-percusión en fondo de saco posterior (Douglas).

□ **Toda mujer en edad fértil con dolor abdominal y test de embarazo positivo tiene embarazo ectópico hasta demostrar lo contrario.**

4. Diagnóstico

El diagnóstico se basa en la **correlación clínica, ecográfica y hormonal (hCG).**

a.

Test de embarazo

- Cualquier test de orina o suero **positivo** confirma embarazo, pero no su localización.
 - Una **β -hCG positiva sin evidencia ecográfica de saco intrauterino** orienta a embarazo ectópico o embarazo muy precoz.
-

b.

hCG sérica cuantitativa

La **zona discriminatoria ecográfica** corresponde al nivel de β -hCG por sobre el cual debería visualizarse un saco intrauterino normal:

Ecografía	Zona discriminatoria
Transvaginal (TV)	1.500–2.000 mUI/mL
Transabdominal (TA)	6.000–6.500 mUI/mL
• Si hCG >2.000 mUI/mL y no hay saco intrauterino, se diagnostica embarazo	

ectópico hasta demostrar lo contrario.

- En un embarazo intrauterino viable, la hCG **debe duplicarse cada 48 h.**
 - Un aumento <66% o estancamiento indica **embarazo no evolutivo o ectópico.**
-

c.

Ecografía transvaginal

Es el **método diagnóstico de elección.**

Hallazgos característicos:

- **Ausencia de saco intrauterino** con hCG >2.000.
- **Masa anexial heterogénea o anillo tubario (“bagel sign”).**
- **Líquido libre en fondo de saco** (hemoperitoneo).
- **Saco gestacional con embrión y latido fuera del útero** (diagnóstico definitivo, poco frecuente).

Sensibilidad: 90–95%

Especificidad: >95%

d.

Culdocentesis / Laparoscopia diagnóstica

Actualmente en desuso, pero útil si el diagnóstico sigue incierto y la paciente está inestable:

- Presencia de **sangre no coagulable en fondo de saco posterior** confirma hemoperitoneo.
-

5. Clasificación

Tipo de embarazo ectópico	Frecuencia	Particularidades
Tubario (98%)	—	Principalmente ampular (70%)
Ístmico (12%)	—	Ruptura precoz y grave
Fímbrico (11%)	—	Puede abortar espontáneamente
Intersticial o cornual (2%)	—	Alta mortalidad, ruptura tardía
Ovario / Cervical / Abdominal	<1%	Diagnóstico difícil, mayor riesgo hemorrágico

6. Manejo (según estabilidad y criterios MINSAL)

El tratamiento puede ser **médico, quirúrgico o expectante**, según la condición clínica y los valores de hCG.

A.

Manejo médico con metotrexato (MTX)

Indicaciones:

- Paciente hemodinámicamente estable.
- Diagnóstico confirmado de embarazo ectópico.
- Sin latido embrionario.
- β -hCG <5.000 mUI/mL.

- Masa anexial <3,5–4 cm.
- Ausencia de hemoperitoneo importante.
- Deseo de preservar fertilidad.

Esquema clásico (MINSAL y OMS):

- **Metotrexato 50 mg/m² IM dosis única.**
- Medir hCG en días 4 y 7:
 - Si desciende $\geq 15\%$ entre ambos → éxito terapéutico.
 - Si no → repetir dosis o pasar a cirugía.
- Control semanal hasta negativización de hCG.

Contraindicaciones:

- Inestabilidad hemodinámica.
- Insuficiencia hepática o renal.
- Lactancia, anemia o leucopenia grave.
- Sospecha de ruptura tubaria.

Efectos adversos: náuseas, estomatitis, elevación transitoria de transaminasas.

B.

Manejo quirúrgico

Indicaciones:

- Ruptura tubaria o shock.
- Hemoperitoneo importante.
- Contraindicación a MTX.
- β -hCG >5.000 mUI/mL o masa >4 cm.

Opciones:

1. **Salpingostomía laparoscópica** (preserva trompa).
 - Indicada si trompa sana y deseo de fertilidad.
2. **Salpingectomía** (resección completa).
 - Indicada si trompa rota, dañado o paciente sin deseo reproductivo.

☐ La **laparoscopia** es preferida en pacientes estables; **laparotomía** en inestabilidad o hemorragia activa.

C.

Manejo expectante

En casos seleccionados:

- hCG <1.000 mUI/mL y descendiendo espontáneamente.
- Asintomática y sin líquido libre.
- Seguimiento estrecho con hCG cada 48 h y ecografía semanal.

Éxito: 60–80% en embarazos autolimitados.

7. Complicaciones

Tipo	Descripción
Hemorrágicas	Ruptura tubaria → hemoperitoneo → shock hipovolémico
Infecciosas	Endometritis, salpingitis postoperatoria
Reproductivas	Infertilidad secundaria, recurrencia (10–15%)

Farmacológica Toxicidad por MTX (rara con dosis única)
S

- El riesgo de **repetir embarazo ectópico** es de 10–15% tras uno previo y 30% tras dos.

8. Seguimiento y educación

- Control semanal de **β-hCG** hasta negativización.
- Uso de anticonceptivos por al menos **3 meses post MTX**.
- Evitar embarazo por 6 meses si se usó MTX.
- Educación sobre signos de alarma:
 - Dolor abdominal súbito.
 - Mareo o síncope.
 - Sangrado abundante.

9. Diagnóstico diferencial

Condición	Diferencias clave
Aborto espontáneo	Saco intrauterino presente; hCG se eleva y luego desciende.
Quiste hemorrágico de ovario	Test de embarazo negativo.
EPI	Dolor pélvico + fiebre; test embarazo negativo.

Embarazo normal muy precoz

hCG <1.500 y ascenso normal.

10. Perlas clínicas y errores comunes en EUNACOM



Perlas

1. Toda mujer en edad fértil con **dolor pélvico + test positivo = embarazo ectópico hasta descartar.**
2. **Zona discriminatoria:** hCG >1.500 mUI/mL (eco TV) sin saco intrauterino = ectópico.
3. **Metotrexato** indicado si hCG <5.000 y paciente estable.
4. **Ruptura tubaria:** shock hipovolémico + líquido libre = cirugía urgente.
5. **Control hCG día 4 y 7** tras MTX (descenso $\geq 15\%$ = éxito).
6. Riesgo de **recurrencia 10–15%.**



Errores comunes

- Esperar ecografía “definitiva” en paciente inestable.
 - Usar MTX con latido embrionario o masa grande.
 - No medir hCG seriada para seguimiento.
 - Omitir anticoncepción post-MTX.
 - Confundir embarazo ectópico intersticial con gestación normal (saco excéntrico).
-

11. Resumen final (5–7 ideas clave)

1. El **embarazo ectópico** es la **implantación fuera del útero**, usualmente en la trompa (98%).
2. Clínica clásica: **atraso menstrual + dolor pélvico + sangrado vaginal**.
3. **Diagnóstico:** hCG >1.500 + eco sin saco intrauterino.
4. **Tratamiento médico:** metotrexato 50 mg/m² IM (si hCG <5.000, masa <4 cm, estable).
5. **Tratamiento quirúrgico:** salpingostomía o salpingectomía (si roto o inestable).
6. **Ruptura tubaria → urgencia vital → cirugía inmediata.**
7. **Seguimiento con hCG** hasta valores indetectables; anticoncepción posterior recomendada.